

01

消化器症状

悪心・嘔吐・下痢・口内炎・便秘

1 薬剤の分類マップ

悪心・嘔吐 催吐性リスクで分類	高度催吐性	シスプラチン	AC/EC療法	シクロホスファミド(大量)			
	中等度催吐性	カルボプラチン	オキサリプラチン	イリノテカン	ドキシソルビン		
	軽度催吐性	タキサン系	5-FU	ゲムシタビン	ペメトレキセド		
下痢 薬剤ごとに機序が異なる	細胞障害性抗がん薬	イリノテカン	5-FU	カペシタビン	S-1	FTD/TPI	
	分子標的薬	アファチニブ	アベマシクリブ	ラパチニブ	レゴラフェニブ		
	ICI(大腸炎)	ニボルマブ	イピリムマブ	ペムブロリズマブ			
口内炎 口腔粘膜の障害	代謝拮抗薬	5-FU	S-1	メトトレキサート	アントラサイクリン・タキサン	ドキシソルビン	ドセタキセル
	mTOR阻害薬(高頻度)	エベロリムス					
便秘 腸管運動の低下	抗がん薬	ピンクリスチン	ビノレルビン	支持療法の薬剤	5-HT3受容体拮抗薬	オピオイド	

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 催吐性リスク分類と制吐療法の組み合わせ

催吐性リスク	代表的な薬剤	1日目(急性期)	2日目以降(遅発期)
高度 (90%超)	シスプラチン、AC/EC療法、シクロホスファミド(大量)	NK1受容体拮抗薬+5-HT3受容体拮抗薬+デキサメタゾン+オランザピン	デキサメタゾン+オランザピン(2〜4日目)
中等度 (30〜90%)	カルボプラチン、オキサリプラチン、イリノテカン、ドキシソルビン	5-HT3受容体拮抗薬+デキサメタゾン(カルボプラチンはNK1受容体拮抗薬を追加)	デキサメタゾン(2〜3日目、省略できる場合あり)
軽度 (10〜30%)	タキサン系、5-FU、ゲムシタビン、ペメトレキセド	デキサメタゾン、または5-HT3受容体拮抗薬・メトクロプラミドの単剤	原則不要
最小度 (10%未満)	ピンクリスチン、多くの抗体薬(ペバシズマブ等)	原則不要	原則不要

2日目以降の内服薬は保険薬局で交付されることが多い。具体的な薬剤・用量・日数は制吐薬適正使用ガイドラインと各施設のレジメンで確認する。

3 副作用の特徴と発現時期

	投与前	投与日	3日	1週	2週	1か月〜
● 予期性の悪心・嘔吐		過去のつらい経験から				
● 急性の悪心・嘔吐		24時間以内				
● 早発性下痢(イリノテカン)		投与中〜24時間				
● 遅発性の悪心・嘔吐			2〜5日目			
● 便秘(制吐薬・ピンカ)			投与後数日			
● 遅発性下痢(イリノテカン)			投与後数日〜			
● 口内炎				5日目〜2週間		
● ICI大腸炎					数週〜数か月	

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 制吐療法は催吐性リスクで決まる。高度リスクはNK1+5-HT3+デキサメタゾン+オランザピンの4剤
2. 下痢は原因薬剤で対応が異なる。ICI大腸炎は口ペラミドや市販の下痢止めで様子を見ない
3. 症状の多くは帰宅後に起こる。薬局がGradeで記録・共有し、次コースの制吐療法の調整につなげる